



MALFORMATIONS DE LA VESSIE

I. Malformations de volume

A. Agénésie vésicale:

- absence complète de la vessie urinaire;
- très rare ;
- accompagnée d'autres anomalies réno-urinaires, quelques fois incompatibles avec la vie;
- les uretères s'ouvrent dans un reste trigonal ou dans le vagin;
- le traitement consiste en diverses méthodes de dérivation urinaire interne ou externe.



Agénésie complète de l'appareil urinaire : rein et uretères



MALFORMATIONS DE LA VESSIE

Malformations de volume

B. Hypoplasie de la vessie:

-Clinique:

- mictions fréquentes,
- incontinence urinaire.

- Traitement:

- diverses méthodes de recalibrage (entéro-cystoplastie d'augmentation);
- réimplantation urétérale;
- plastie du col vésical





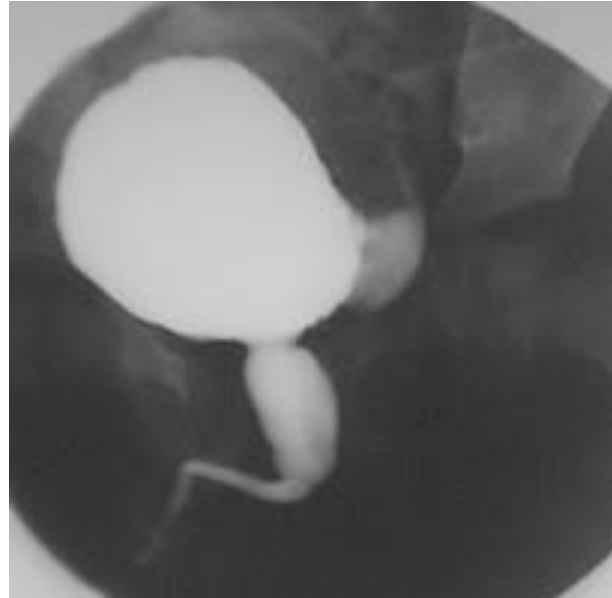
MALFORMATIONS DE LA VESSIE

Malformations de volume

C. Méga vessie - peut être:

Secondaire:

- sténose du col vésical;
- obstacle sous-vésical;
- spina bifida (vessie neurogène).





MALFORMATIONS DE LA VESSIE

Malformations de volume

C. Méga vessie

Primitive:

- s'associe à l'ectasie des uretères réalisant le **syndrome de mégavessie-mégauretère**;
- se doit aux troubles d'innervation de la vessie et des uretères par **aplasie des plexus nerveux intra-muraux**;
- est affecté le **trigone vésical** (innervation sympathique) et le **sphincter interne**;
- à cause du **dysynergisme de détrusor** (innervation parasympathique), se produit **l'hypertrophie avec augmentation du volume vésical**;
- au niveau des uretères s'enregistre un défaut de péristaltique et de dilatation primaire et (ou) secondaire au reflux vésico-urétéral passif;



MALFORMATIONS DE LA VESSIE

Malformations de volume

C. Méga vessie

- une forme particulière de **mégavessie-mégauretère** se rencontre dans le syndrome « **Prune-Belly** » qui inclut aussi:
- **l'aplasie de la musculature** de la paroi abdominale (aspect de « prune séchée »);
- **cryptorchidie bilatérale**.





MALFORMATIONS DE LA VESSIE

Symptomatologie clinique

- sont superposables aux **infections urinaires** d'habitude existantes;
- épisodes fréquents de **rétention urinaire aiguë**;
- au sondage de la vessie urinaire on évacue une quantité impressionnante d'urine;

Examens de laboratoire:

- l'urographie,
- cystographie précise le diagnostic.

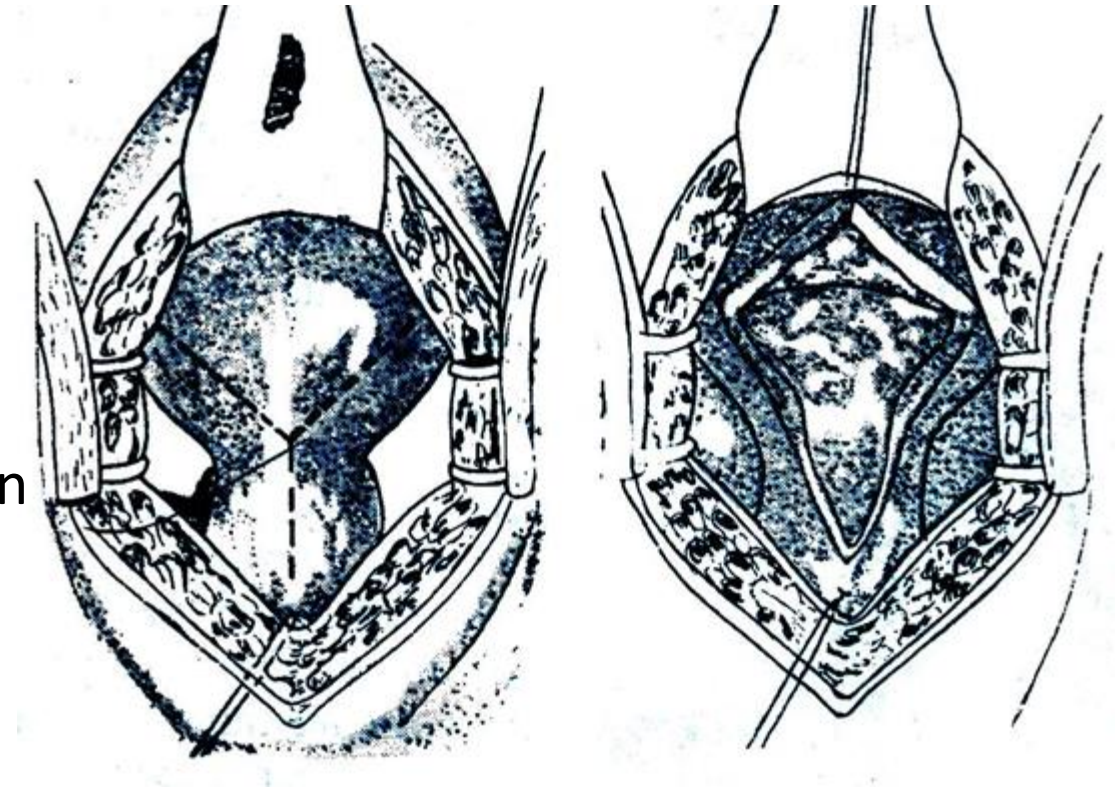




MALFORMATIONS DE LA VESSIE

Traitement:

- médical – s'adresse aux infections urinaires;
- chirurgical - plastie du col vésical en YV d'après le procédé Young avec bons résultats en général



Plastie de col vesical YV Young



MALFORMATIONS DE LA VESSIE

II. Malformations de forme

A. Dédoublement de la vessie urinaire:

- habille deux formes anatomo-cliniques:

Vessie bipartite - par intermédiaire d'un septum antéro-postérieur incomplet, inversé face au col vésical.

Vessie double - par septum complet antéro-postérieur, chaque compartiment ayant son uretère propre, existant souvent un double-uretère.

- symptomatologie:

- est atypique ainsi le diagnostic se précise par explorations imagistiques.

- **Traitement:**

- résection du septum médian



MALFORMATIONS DE LA VESSIE

II.

Malformations de forme

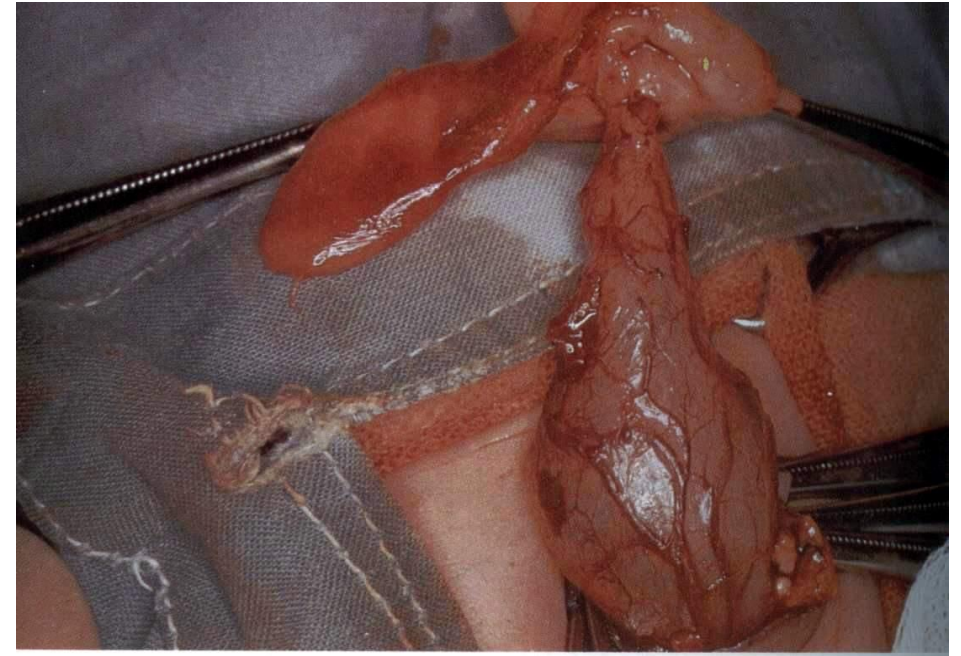
B. Vessie en clepsydre:

- se doit à la présence d'un septum transversal ou d'une sténose congénitale.

C. Diverticules vésicaux congénitaux:

- uni- ou bilatéraux, situés dans d'habitude juxta-urétéral;
- ceux situés aux pôles supérieurs de la vessie sont des diverticules d'ouraue;
- miction en « 2 temps » associées à des signes d'infection urinaire;
- diagnostic précisé par cystographie;

Traitement : résection des diverticules par voie endo-vésicale



vessie en clepsydre (étagée):



MALFORMATIONS DE LA VESSIE

III. Extrophie vésicale

- malformation la plus grave de la vessie;
- fréquence de 1/30.000- 50.000 naissances;
- est de 4 fois plus fréquente chez le sexe masculin;
- s'associe avec d'autres lésions avoisinantes dans le contexte d'une aplasie régionale (disjonction de symphyse pubienne, diastase des droits abdominaux, cryptorchidie, épispadias) -coelosomie inférieure;
- présente 3 grands problèmes:
 1. la continence urinaire;
 2. la fonction rénale;
 3. la fonction sexuelle



MALFORMATIONS DE LA VESSIE

Embryo-pathogénique:

- un défaut de mésodermisation ayant comme conséquence l'aplasie de la paroi antérieure du sinus uro-génital.





MALFORMATIONS DE LA VESSIE

Clinique:

- diagnostique facile à établir, la malformation étant évidente dès la naissance;
- dans la région hypogastrique, la paroi postérieure de la vessie bombe sous la forme d'une **tumeur rouge, ronde**;
- la muqueuse urinaire se continue avec les téguments avoisinants;
- l'ombilic manque, à sa place se trouvant un pli cutané;
- **les orifices urétéraux sont visibles** dans la portion inférieure, sous la forme d'une tumorette conique, par laquelle s'extériorise de façon intermittente l'urine ;





MALFORMATIONS DE LA VESSIE

Clinique:

- à cause de l'écoulement continu d'urine, **les téguments** avoisinant **s'œdématisent** et s'ulcèrent réalisant une **dermatite ammoniacale**;
- **le trigone vésical ouvert** se continue par une muqueuse urétrale située dans le sillon du **pénis épispadias**;
- chez le sexe féminin **le clitoris** et quelques fois **le vagin** **sont fragmentés**;
- chez le sexe masculin les **testicules** **sont cryptorchidies**;
- **la malformation du bassin** retarde et modifie la mobilité.





MALFORMATIONS DE LA VESSIE

Diagnostic positif:

- **l'urographie** précise l'état fonctionnel du rein et les éventuelles malformations réno-urétérales associées.

Pronostique:

- les soins apportés à l'enfant sont difficiles et apparaissent des modifications psychiques;
- le pronostique vital est ombré par la pyélonéphrite;
- sans intervention chirurgicale 60% des cas décèdent sous l'âge de 10 ans.

Traitement: - trois objectifs:

- 1. **création d'un réservoir urinaire continent;**
- 2. **conservation de la fonction rénale;**
- 3. **aspect anatomo-fonctionnel de l'appareil génital le plus acceptable possible.**



MALFORMATIONS DE LA VESSIE

Traitement:

La reconstruction vésicale primaire (Cendron - Young) chez le nouveau-né:

- se pratique dans la première année de vie;
- est souvent un échec;
- la majorité des cas où la procédure réussit développent une incontinence urinaire.

Dérivation urinaire de type uretéro-sigmoïde-stomie (Coffey):

- les résultats immédiats sont bons;
- à distance - **acidose chronique hyper-chlorémique et pyélonéphrite.**

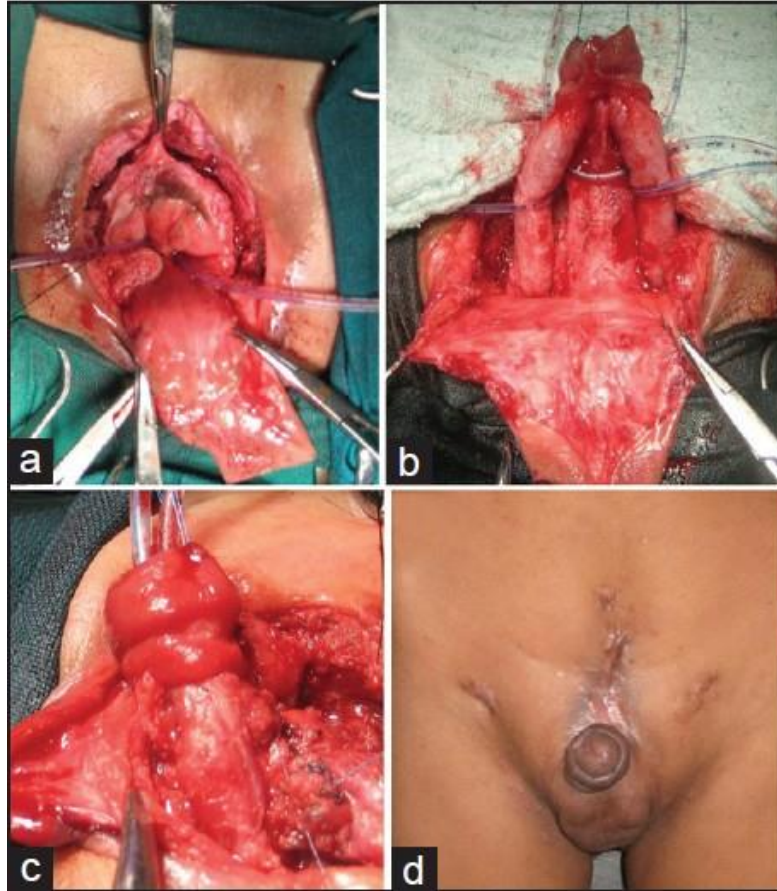
Urétérostomie cutanée trans-iléale (Bricker);

Néo-vessie rectale contrôlée par le sphincter anal (Hovelacque-Duhamel).

- la résolution de la cryptorchidie et les interventions plastiques reconstructives sur l'appareil génital peuvent rétablir une fonction sexuelle satisfaisante.



MALFORMATIONS DE LA VESSIE



Néo-vessie rectale contrôlée
par le sphincter anal

